

AULA • NÍVEL BÁSICO

Engasgo: quando o ar não passa

Reconhecer. Chamar ajuda. Intervir.

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio

Fonte: Base: AHA — Highlights of the 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC (PDF oficial) e Adult Foreign-Body Airway Obstruction Algorithm, BLS 2025 [1][2]; identificação do instrutor fornecida pelo usuário.



Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio

APRESENTAÇÃO

Quem conduz esta conversa

1º Tenente Geraldo

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

FORMAÇÃO ACADÊMICA



Engenharia Química — UFPE • Pós-graduação em APH

ATUAÇÃO OPERACIONAL



CBMPE: operações de APH; resgate veicular; piloto de embarcações públicas; incêndio florestal

Especialista em ocorrências com produtos perigosos — CBMBA

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

O almoço de domingo

- Um adulto come rápido e fala enquanto mastiga.
- De repente, para de falar: fica pálido e leva as mãos ao pescoço.
- A tosse é fraca e some em poucos segundos.



O que fazer nos primeiros minutos?

Fonte: Sinais de obstrução grave: AHA — Highlights 2025, seção 'Foreign-Body Airway Obstruction'; ERC 2025 First Aid (Resuscitation 2025;215(Suppl 1):110752). História: simulação editorial.



A primeira decisão: leve ou grave



LEVE



LEVE: tosse com força, consegue falar ou chorar, emite som.



Conviver e observar: encorajar a tosse e vigiar sinais de piora.



GRAVE



GRAVE: tosse fraca ou ausente, não consegue falar, muda de cor.



Se a obstrução é grave, a decisão é agir — e não esperar.

Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

Adulto e criança acima de 1 ano: 5 e 5

-  Ciclos repetidos de 5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões abdominais.
-  Repetir até o objeto sair ou a pessoa ficar inconsciente.
-  **Se o objeto sair, parar a manobra imediatamente.**
-  Depois do alívio, manter a pessoa em observação até a chegada do cuidado.



Esquema original • pictogramas Phosphor • não demonstra técnica

Quando trocar o abdominal pelo torácico



Gestação no final

- Gestação no final da gravidez: 5 compressões torácicas no lugar das abdominais.



Abdome que não se consegue circundar

- Quando não se consegue circundar o abdome: também compressão torácica.

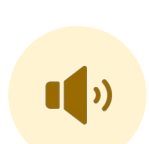


O critério é técnico, não o biotipo da pessoa.

Nas demais situações do adulto e da criança, mantém-se o ciclo abdominal.

Ilustração vetorial original • não demonstra técnica

Bebê com menos de 1 ano: 5 e 5, mas diferentes

-  Ciclos de 5 golpes nas costas alternados com 5 compressões torácicas.
-  **Compressão abdominal NÃO é recomendada no bebê.**
-  Motivo da fonte: risco de lesão de órgãos abdominais.
-  **Interromper imediatamente se aparecer alívio: tosse, respiração audível ou choro.**



Esquema original • pictogramas Phosphor • não demonstra técnica

Três versões de 2025 para a compressão no bebê



AHA 2025

compressão torácica com
o calcanhar de uma mão.



ERC 2025

dois polegares
circundando o tórax.



SBP 2025 (Brasil)

dois dedos logo abaixo
da linha mamilar.



As três são de 2025 — siga a de quem treina você, e saiba dizer de onde ela vem.

Pictogramas: Phosphor • comparação textual, não demonstra técnica

Se a pessoa ficar inconsciente



1

Iniciar a reanimação com compressões.



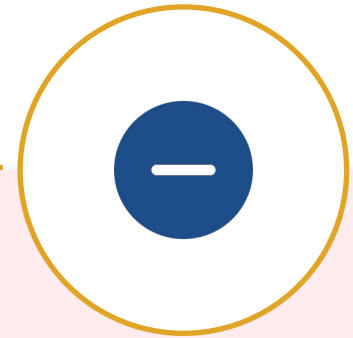
2

Antes de cada ventilação, olhar se há objeto visível na boca.



3

Retirar apenas o que está visível.



4

Varredura às cegas dentro da boca é proibida.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor • esquema não demonstra técnica

O que o público geral faz — e o que não faz



FAZ

- ✓ FAZ: reconhecer o grave, acionar a emergência, aplicar 5 golpes e 5 compressões.
- ✓ FAZ: retirar só o objeto visível e iniciar compressões se a pessoa desmaiar.



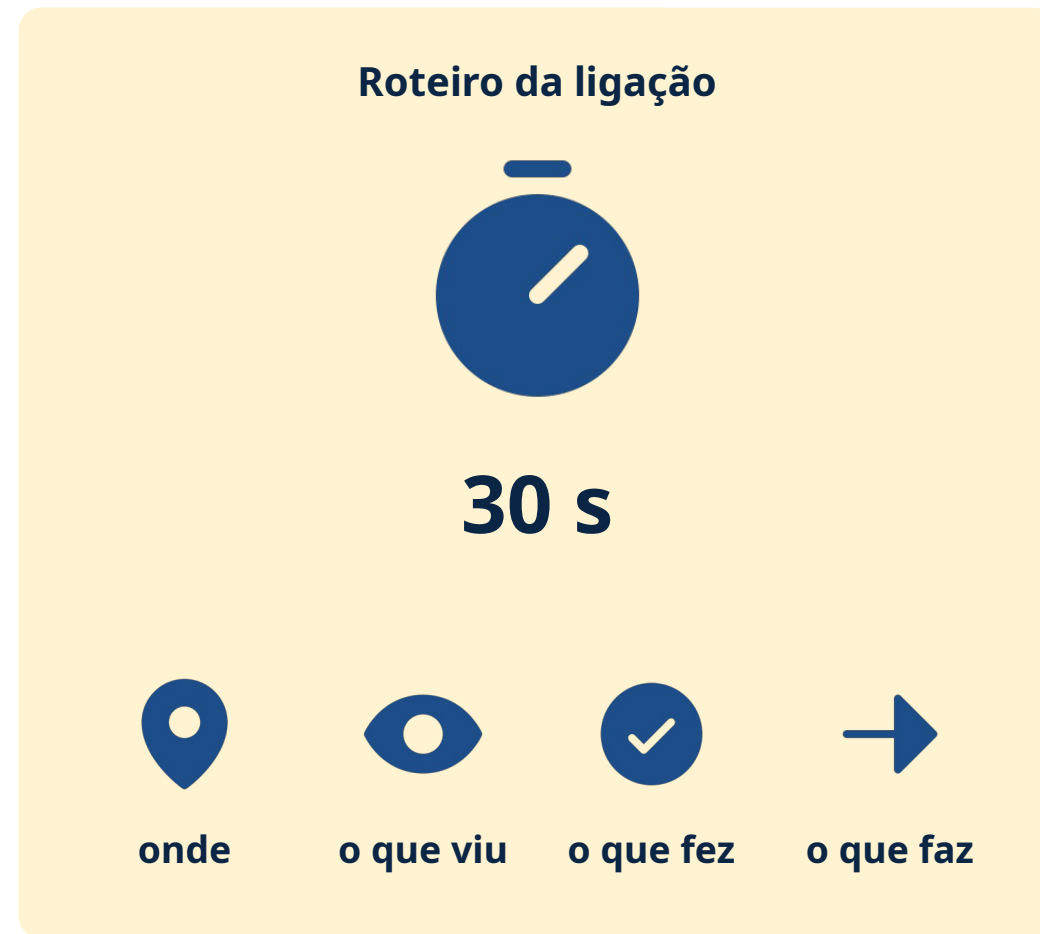
NÃO FAZ

- ✗ NÃO FAZ: varredura às cegas na boca ou na garganta.
- ✗ NÃO FAZ: compressão abdominal em bebê; manobra em quem tosse com força e fala.

Quadro tipográfico original • pictogramas Health Icons e Phosphor

Quando chamar e o que dizer na ligação

-  Verificar segurança da cena, checar os sinais de obstrução grave e acionar 192/193.
-  **Não esperar a pessoa perder a consciência para chamar ajuda.**
-  Na ligação: onde aconteceu, o que foi visto, o que já foi feito e o que se faz agora.
-  Treine cada aluno dizendo isso em voz alta, em 30 segundos.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

O que deve ser feito primeiro em caso de emergência?

Opção 1

RESPOSTA CORRETA

Reconhecer



Chamar ajuda



Intervir

Opção 2

NÃO É A REGRA GERAL

Reconhecer



Intervir



Chamar ajuda

NA PRÁTICA



Com celular: viva-voz e já comece os 5 golpes e as 5 compressões.



Com mais gente: um liga para 192/193; o outro já intervém.



Obstrução grave: acione e intervenha sem esperar a pessoa desmaiar.



Ilustração: unDraw (licença livre) • pictogramas: Health Icons e Phosphor

Engasgo por líquido: a leitura brasileira



SBP 2025 (Brasil)



Bebê engasgado com leite, fórmula, suco ou saliva: conduta diferente.



Sentar ou semissentar a criança, retirar o excesso de líquido da boca com lenço e observar.



Se não voltar a respirar e perder a consciência: chamar ajuda e iniciar a reanimação.



AHA • ERC • ILCOR 2025



As fontes internacionais não separam sólido de líquido — a divergência fica declarada.



Quadro tipográfico original • pictogramas Health Icons e Phosphor

Prevenção: quem engasga e com o que



90% dos casos ocorrem em menores de 5 anos; 65% em menores de 1 ano.



Risco: objetos pequenos — balões, moedas, pilhas, brinquedos.



Risco: alimentos — uva, carne, salsicha, castanha, cenoura crua, maçã, pipoca, bala dura.



Balões lideram como causa letal de engasgo em menores de 6 anos.

Gráficos nativos editáveis • Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

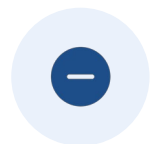
Prevenção: como é o objeto perigoso



Alto risco: objeto cilíndrico, oval, compressível.



Alto risco: tamanho semelhante ao da via aérea da criança.



Formato que pode ocluir completamente a passagem de ar.

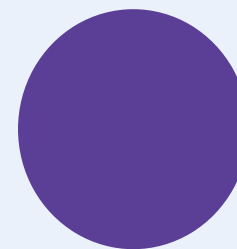


O que fazer em casa: supervisão, distância ao alcance e alimentação sentada.

Formas de alto risco × via aérea



cilíndrico

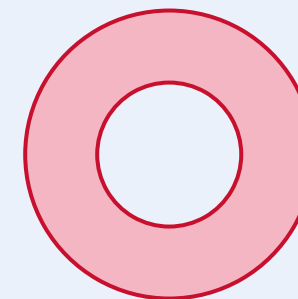


oval



compressível

*mesmo tamanho
= pode ocluir*



*via aérea da
criança*

Ilustração vetorial original • formas esquemáticas, fora de escala

Oito meses e um pedaço de cenoura

- Um bebê de 8 meses engasga com um pedaço de cenoura crua.
- Ele para de emitir som e muda de cor.
- A mãe está sozinha com o bebê no colo.



Qual conjunto de ações está correto?

Fonte: AHA — Highlights 2025 e AHA/AAP — Part 6: Pediatric BLS 2025; AHA — Adult FBAO Algorithm 2025 (Box 6). Caso simulado.



A uva da festa

- Numa festa, uma criança de 3 anos pega uma uva inteira da mesa.
- Começa a tossir com força, mas consegue chorar e falar.
- Um adulto já se prepara para bater nas costas.



O que deve ser feito?

Fonte: SBP — Guia Prático nº 222, 01/08/2025 (alimentos de risco e obstrução parcial); AHA — Highlights 2025 (leve x grave). História: simulação editorial.



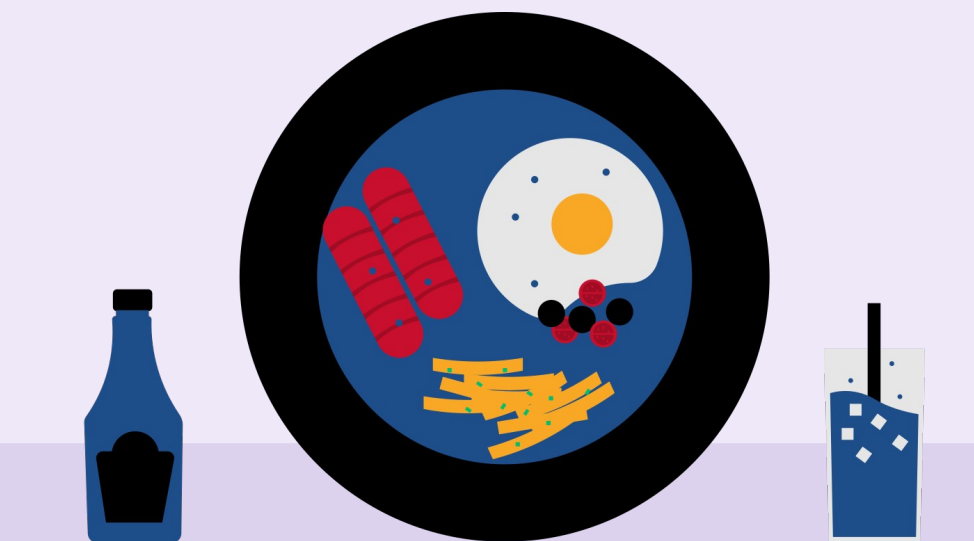
O jantar do avô

- Um homem de 78 anos, com prótese dentária, come carne em pedaços grandes.
- Para de falar no meio da frase, tosse fraco e não emite som.
- A filha está ao lado, com o telefone na mão.



Qual é o primeiro passo e o que vem depois?

Fonte: AHA — Highlights 2025 e AHA — Adult FBAO Algorithm 2025 (Box 4 e Box 6). História: simulação editorial.



Caso da turma: o que fazer primeiro



Caso: adulto come e conversa ao mesmo tempo, para de falar, tosse fraco e leva as mãos ao pescoço. Está consciente.

A

Bater nas costas uma vez e esperar.

B

Iniciar ciclos de 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais, chamar a emergência e repetir.

C

Colocar o dedo na garganta para procurar o objeto.

D

Esperar a tosse resolver sozinha.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

RECAPITULANDO

Recapitulando o essencial

-  Leve: tosse com força e emite som — encorajar a tosse e observar.
-  **Grave: não emite som — intervir, sem esperar.**
-  Adulto e criança acima de 1 ano: 5 golpes nas costas + 5 compressões abdominais.
-  Bebê: 5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas, sem abdominal.
-  **Inconsciente: reanimação e só retirar o que estiver visível.**



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 1 — Reconhecer a obstrução grave



Qual conjunto de sinais indica obstrução de via aérea **GRAVE**?

A

Tosse forte, consegue falar e emitir som

B

Chiado no peito ao respirar e febre

C

Cansaço depois de correr

D

Tosse fraca ou ausente, incapacidade de falar e mudança de cor

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 2 — Adulto consciente com obstrução grave



No adulto consciente com obstrução grave, qual é a sequência recomendada em 2025?

A

Ciclos repetidos de 5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões abdominais, até o objeto sair ou a pessoa ficar inconsciente

B

Apenas 5 golpes nas costas e aguardar

C

Compressões torácicas com a pessoa deitada no chão, mesmo consciente

D

Varredura com o dedo na garganta até encontrar o objeto

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 3 — Bebê com obstrução grave



Bebê de 6 meses com obstrução grave. Qual conduta está correta?

A

Compressões abdominais, como no adulto

B

Oferecer água para empurrar o objeto

C

5 golpes nas costas alternados com 5 compressões torácicas, sem compressão abdominal

D

Colocar de cabeça para baixo e sacudir até sair

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 4 — Tosse eficaz



Uma pessoa engasgada tosse com força, consegue falar e está emitindo som. O que orientar?

A

Iniciar imediatamente os golpes nas costas e as compressões

B

Encorajar a tosse e continuar observando sinais de piora

C

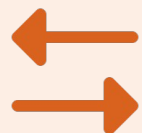
Deitar a pessoa e iniciar compressões torácicas

D

Fazer varredura com o dedo para retirar o objeto

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Questão 5 — Substituição por compressões torácicas



Em quais duas situações, no adulto, a fonte AHA 2025 orienta usar 5 compressões torácicas em vez das abdominais?

A

Em pessoas idosas e em pessoas com tosse fraca

B

Na gestação no final e quando o socorrista não consegue circundar o abdome da pessoa

C

Sempre que a pessoa estiver sentada

D

Quando a pessoa já perdeu a consciência e está em parada

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Gabarito comentado

1 – **D** tosse fraca ou ausente, não fala, muda de cor.

2 – **A** ciclos de 5 golpes nas costas + 5 compressões abdominais.

3 – **C** no bebê, 5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas, sem abdominal.

4 – **B** encorajar a tosse e observar — obstrução leve.

5 – **B** gestação no final e quando não se consegue circundar o abdome.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Referências — diretrizes internacionais



AHA — Highlights of the 2025 Guidelines for CPR and ECC (PDF oficial).



AHA — Adult Foreign-Body Airway Obstruction Algorithm, BLS 2025.



AHA/AAP — Part 6: Pediatric Basic Life Support, 2025.



ILCOR — CoSTR: Removal of foreign body airway obstruction (BLS 368), 2025.



ERC — Guidelines 2025 First Aid; ERC 2025 Paediatric Life Support.

Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

Referências — fonte brasileira e divergências declaradas

SBP — Guia Prático de Atualização nº 222, de 01/08/2025 (obstrução por corpo estranho e engasgo por líquidos).



SBP — Curso de Suporte Básico de Vida, gestão 2022-2024.



Onde as diretrizes divergem, as versões aparecem lado a lado, com a origem nomeada.



DIVERGÊNCIA DECLARADA

Três divergências neste tema: bebê; gestante no final e obesidade; engasgo por líquido.



Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)

AULA • NÍVEL BÁSICO

Engasgo: quando o ar não passa

Reconhecer. Chamar ajuda. Intervir.

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

Material didático de apoio

Fonte: Base: AHA — Highlights of the 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC (PDF oficial) e Adult Foreign-Body Airway Obstruction Algorithm, BLS 2025 [1][2]; identificação do instrutor fornecida pelo usuário.



Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio